

Relações entre mente e corpo: uma revisão crítica dos fundamentos, das evidências e dos limites da recuperação física

Carlos Hernane de Oliveira¹

RESUMO

A participação de processos psicológicos na recuperação física constitui um problema central da Psicologia da Saúde, mas permanece sujeita a interpretações causais excessivas e a generalizações indevidas. Este artigo desenvolve uma revisão narrativa crítica sobre as relações entre estresse, experiências emocionais, intervenções psicológicas e desfechos corporais. O argumento central é que a expressão "cura do corpo" precisa ser decomposta em resultados verificáveis, tais como alívio de sintomas, recuperação funcional, melhora da qualidade de vida, modificação de marcadores fisiológicos e reparação tecidual. A literatura examinada indica associações entre estresse e cicatrização, efeitos pequenos ou incertos de intervenções de atenção plena sobre dor crônica, efeitos promissores de intervenções psicológicas em feridas e influência do contexto terapêutico em sintomas gastrointestinais. Esses achados não demonstram, contudo, que doenças possuam significados simbólicos universais ou que conflitos psíquicos substituam diagnóstico e tratamento médico. Como contribuição, propõe-se uma matriz crítica que separa associação, mecanismo, intervenção, experiência e interpretação simbólica. A abordagem preserva a subjetividade do paciente, incorpora fatores sociais e mantém as conclusões proporcionais ao desenho e aos desfechos de cada estudo (MCEWEN, 2017; HILTON *et al.*, 2017; ROBINSON *et al.*, 2017).

Palavras-chave: Psicologia da Saúde; relações mente-corpo; estresse psicológico; recuperação física; psicossomática; medicina narrativa.

ABSTRACT

The participation of psychological processes in physical recovery is a central problem in Health Psychology, but it remains vulnerable to excessive causal interpretations and unwarranted generalizations. This article develops a critical narrative review of the relationships among stress, emotional experiences, psychological interventions, and bodily outcomes. Its central argument is that the expression "healing of the body" must be decomposed into verifiable outcomes, including symptom relief, functional recovery, quality of life, physiological markers, and tissue repair. The literature indicates associations between stress and wound healing, small or uncertain effects of mindfulness interventions on chronic pain, promising effects of psychological interventions on wounds, and contextual effects on gastrointestinal symptoms. These findings do not demonstrate that diseases have universal symbolic meanings or that psychological conflicts can replace medical diagnosis and treatment. The article contributes a critical matrix that distinguishes association, mechanism, intervention, experience, and symbolic interpretation, while preserving the patient's subjectivity and keeping conclusions proportional to study design and outcomes (MCEWEN, 2017; HILTON *et al.*, 2017; ROBINSON *et al.*, 2017).

Keywords: Health Psychology; mind-body relations; psychological stress; physical recovery; psychosomatics; narrative medicine.

¹Escola de Governo Henrique Santillo. E-mail: carlos.holiveira@goias.gov.br.

1 INTRODUÇÃO

Quando uma pessoa adoece, os efeitos da condição raramente se restringem ao órgão inicialmente afetado. A dor pode alterar o sono, limitar o trabalho, modificar relações sociais e produzir expectativas negativas sobre o futuro. Esses efeitos não significam que a doença seja imaginária ou exclusivamente psicológica; indicam que o adoecimento envolve simultaneamente processos biológicos, experiências subjetivas e condições de vida. Na dor crônica, intensidade, sofrimento, incapacidade e participação social constituem dimensões relacionadas, mas não idênticas, do impacto clínico (TREEDE *et al.*, 2015).

A investigação das relações entre mente e corpo procura compreender como processos neurais, endócrinos, imunológicos, comportamentais e sociais participam das trajetórias de saúde. O conceito de alostase descreve a capacidade de alcançar estabilidade por meio de mudanças adaptativas, enquanto a carga alostática designa o custo acumulado de respostas prolongadas, desreguladas ou desproporcionais às exigências ambientais. Essa formulação oferece mecanismos investigáveis sem presumir que todo adoecimento seja causado por conflito emocional (MCEWEN, 2006; MCEWEN, 2017).

O tema também é atravessado por propostas que atribuem aos sintomas um conteúdo simbólico. Em *A doença como caminho*, Dethlefsen e Dahlke compreendem a doença como expressão de conflitos internos e procuram interpretar o corpo como linguagem. A obra é relevante para a história cultural das concepções mente-corpo, mas sua coerência metafísica não constitui, por si só, demonstração experimental de causalidade ou de eficácia terapêutica. A análise acadêmica precisa reconhecer essa diferença para não converter uma interpretação simbólica em evidência clínica que os autores não testaram (DETHLEFSEN; DAHLKE, 2002).

O problema científico surge quando resultados sobre estresse, dor, relaxamento ou intervenções psicológicas são utilizados para confirmar explicações simbólicas específicas que os estudos não investigaram. A melhora de um sintoma após uma prática de relaxamento pode decorrer de múltiplos componentes, incluindo expectativa, relação terapêutica, autorregulação, mudança comportamental ou flutuação natural da condição. Do mesmo modo, a alteração de um marcador biológico não equivale automaticamente à cura da doença nem demonstra a existência de um conflito psíquico correspondente (KUO *et al.*, 2015; KAPTCHUK *et al.*, 2010).

A pergunta que orienta este artigo é: de que maneira processos e intervenções psicológicas podem contribuir para a recuperação física e quais limites as evidências impõem a essa contribuição? O objetivo geral é analisar criticamente mecanismos, associações,

experiências e resultados clínicos relacionados às relações mente-corpo. O objetivo específico é propor um modo de discutir interpretações simbólicas sem desqualificar a experiência do paciente e sem abandonar os padrões de precisão exigidos pela pesquisa científica (BORRELL-CARRIÓ; SUCHMAN; EPSTEIN, 2004; CHARON, 2001).

A contribuição original do artigo consiste em organizar o debate por níveis de afirmação. Uma pesquisa pode mostrar uma associação entre exposição e desfecho, investigar um mecanismo fisiológico, avaliar uma intervenção, descrever uma experiência ou propor uma interpretação simbólica. Esses níveis podem dialogar, mas não são intercambiáveis. A passagem de um nível a outro exige evidência adicional, definição do desfecho e consideração de explicações alternativas (BAETHGE; GOLDBECK-WOOD; MERTENS, 2019; MCEWEN, 2017).

2 PERCURSO METODOLÓGICO

Este estudo adota a forma de revisão narrativa crítica. A escolha é adequada ao objetivo de integrar literaturas heterogêneas e examinar como diferentes desenhos de pesquisa sustentam afirmações distintas. Não se pretende estimar um efeito conjunto nem apresentar uma revisão sistemática de toda a produção disponível. A transparência sobre a pergunta, o percurso de seleção, a natureza das fontes e os limites da síntese é tratada como requisito de qualidade para revisões narrativas (BAETHGE; GOLDBECK-WOOD; MERTENS, 2019).

O corpus de partida foi constituído por um acervo de 100 textos completos em acesso aberto, selecionados em bases da Europe PMC e da PubMed Central por sua relação com psicossomática, psiconeuroimunologia, estresse, intervenções mente-corpo, dor crônica, sintomas gastrointestinais, dermatologia, hipertensão e modelos biopsicossociais. O acervo foi utilizado como fonte de trabalhos relacionados, não como amostra representativa de toda a literatura mundial. Essa delimitação evita apresentar uma seleção intencional como se fosse um levantamento exaustivo (ÅSLUND *et al.*, 2014; HILTON *et al.*, 2017).

A busca bibliográfica foi realizada na Europe PMC em 21 de setembro de 2026, por meio de sete consultas complementares que combinaram os campos de título e resumo com os operadores booleanos OR e AND, sempre com o filtro OPEN_ACCESS:Y. As consultas contemplaram os termos psychosomatic, psychoneuroimmunology, mind-body, somatic symptom, medically unexplained, psychophysiology, stress, mindfulness, irritable bowel, dermatitis, eczema, hypertension, chronic pain, migraine, biopsychosocial, mind body medicine

e integrative medicine. A API foi consultada com parâmetros técnicos específicos². Não foram aplicados filtros de idioma, ano de publicação ou tipo de documento; foram mantidos os registros que possuíam identificador PMCID, o que permitiu recuperar o texto completo em XML por meio da Europe PMC/PMC. Após a remoção de duplicatas pelo PMCID, a seleção final aplicou uma pontuação de relevância baseada na presença dos termos no título e no resumo, excluindo registros sem relação direta com as relações mente-corpo, a psicossomática, o estresse, as intervenções psicológicas ou a recuperação física (EUROPE PMC, 2026).

Do acervo de 100 textos, um subconjunto de 20 trabalhos foi selecionado para discussão aprofundada neste artigo, por permitir responder de modo mais direto às quatro perguntas que orientaram a análise (associação, mecanismo, intervenção ou experiência). Os demais textos do acervo compuseram a leitura de fundo que sustentou a delimitação do tema, a identificação de conceitos-chave e a formulação das perguntas de análise, sem serem citados diretamente no corpo do artigo. O fluxo da seleção é sintetizado na Tabela 1.

Tabela 1 – Fluxo de seleção dos registros

Etapas	Quantidade	Observação
Consultas realizadas na Europe PMC	7	Campos TITLE e ABSTRACT combinados com os operadores OR e AND; filtro OPEN_ACCESS:Y em todas as consultas.
Registros após deduplicação por PMCID e aplicação da pontuação de relevância	100	O número de resultados brutos por consulta individual e de duplicatas removidas não foi registrado separadamente no log da busca; apenas o total final foi preservado.
Textos selecionados para discussão aprofundada no artigo	20	Selecionados por permitirem responder mais diretamente às quatro perguntas de análise (associação, mecanismo, intervenção, experiência).
Textos remanescentes (leitura de fundo)	80	Utilizados para delimitar o tema e identificar conceitos-chave; não citados diretamente no corpo do artigo.

Fonte: elaborado pelo autor com base no log de busca na Europe PMC.

Os critérios de inclusão foram os seguintes:

- a) registro indexado na Europe PMC com marcação OPEN_ACCESS:Y;
- b) presença de identificador PMCID, permitindo a recuperação do texto completo em XML;
- c) presença de ao menos um dos termos de busca no título ou no resumo;

²Parâmetros da API da Europe PMC: format=json, pageSize=100, resultType=core, sort=CITED desc.

d) relação temática direta com relações mente-corpo, psicossomática, estresse, intervenções psicológicas ou recuperação física, conforme avaliação de pertinência.

Os critérios de exclusão foram os seguintes:

a) registros duplicados, identificados pelo mesmo PMCID recuperado em mais de uma consulta;

b) títulos e resumos sem relação direta com o tema, incluindo artigos biomédicos gerais sem menção a processos psicológicos;

c) registros sem identificador PMCID, cujo texto completo não pôde ser recuperado.

A análise foi orientada por quatro perguntas: o estudo descreve uma associação, investiga um mecanismo, testa uma intervenção ou interpreta uma experiência? Nos ensaios clínicos, foram observados comparadores, tamanho da amostra, duração do seguimento, natureza dos desfechos e informações sobre eventos adversos. Nos estudos observacionais, foram considerados o desenho, a possibilidade de causalidade reversa e os fatores de confusão. Nos trabalhos conceituais, examinou-se a coerência entre os pressupostos e o tipo de conclusão apresentado (BAETHGE; GOLDBECK-WOOD; MERTENS, 2019; HILTON et al., 2017).

A seleção privilegiou artigos que permitissem discutir a relação entre processos psicológicos e manifestações corporais ou esclarecer os limites dessa relação. A presença isolada do termo "estresse" não foi considerada suficiente, pois estresse psicológico, estresse oxidativo e estresse fisiológico são conceitos distintos. A proximidade lexical entre eles não autoriza equivalência causal. O estresse oxidativo, por exemplo, refere-se ao desequilíbrio entre processos oxidantes e defesas antioxidantes, e não constitui indicador específico de repressão emocional (PIZZINO et al., 2017).

A síntese não aplicou uma avaliação formal de risco de viés a todos os 100 textos e não calculou medidas combinadas de efeito. Por isso, as conclusões têm alcance argumentativo e crítico. Os dados quantitativos mencionados foram mantidos apenas quando eram necessários para avaliar a força ou a limitação de uma conclusão específica. A metodologia foi desenvolvida segundo os critérios de clareza, consistência teórica, transparência e proporcionalidade das conclusões exigidos em avaliações editoriais de alto nível (BAETHGE; GOLDBECK-WOOD; MERTENS, 2019).

3 FUNDAMENTOS DAS RELAÇÕES ENTRE MENTE E CORPO

3.1 Estresse, adaptação e carga alostática

Uma resposta de estresse não é necessariamente patológica. Diante de uma exigência imediata, alterações na atenção, na frequência cardíaca, na disponibilidade de energia e na atividade hormonal podem favorecer a adaptação. O problema tende a surgir quando os sistemas são ativados repetidamente, quando a recuperação é insuficiente ou quando a resposta é desproporcional às demandas. A carga alostática permite examinar esse desgaste como resultado de interações entre sistemas, e não como efeito de uma emoção isolada (MCEWEN, 2006; MCEWEN, 2017).

Esse modelo também afasta a ideia de que cada emoção produza uma resposta corporal única e previsível. O organismo integra avaliação da situação, história de aprendizagem, sono, hábitos, exposição ambiental, suporte social e condições econômicas. A relevância do sofrimento psicológico precisa ser investigada em conjunto com esses fatores. Atribuir ao indivíduo responsabilidade moral por sua doença porque ele não controlou suficientemente seus pensamentos constitui uma conclusão sem base adequada e potencialmente danosa (MCEWEN, 2017; ÅSLUND *et al.*, 2014).

A distinção entre escalas de investigação é igualmente necessária. Um mecanismo observado em células ou animais pode contribuir para formular uma hipótese sobre seres humanos, mas não resolve automaticamente uma questão clínica. Uma alteração neuroendócrina ou imunológica pode ser biologicamente relevante sem permitir prever, em uma pessoa específica, a evolução da doença. A passagem da plausibilidade mecanística para a eficácia terapêutica requer estudos clínicos com desfechos definidos (MCEWEN, 2017; PIZZINO *et al.*, 2017).

3.2 Condições sociais e saúde psicossomática

As relações mente-corpo desenvolvem-se em condições concretas de vida. Em uma grande amostra populacional sueca, Åslund e colaboradores examinaram estresse financeiro, apoio social tangível, bem-estar psicológico e sintomas psicossomáticos. Os resultados sugeriram que a ajuda material pode atenuar parte da associação entre dificuldades econômicas e bem-estar psicológico, embora os efeitos para sintomas psicossomáticos não tenham sido uniformes. O estudo mostra que apoio social não é apenas uma disposição emocional, mas também um recurso material e relacional (ÅSLUND *et al.*, 2014).

O desenho observacional, entretanto, não permite concluir que a falta de apoio tenha causado os sintomas ou que sua ampliação necessariamente os elimine. Pessoas com maior sofrimento podem perceber ou utilizar o apoio de modo diferente, e fatores não medidos podem influenciar exposição e desfecho. Ainda assim, a pesquisa é importante porque impede uma

leitura individualizante do sofrimento. A análise psicológica precisa considerar insegurança financeira, trabalho, moradia, discriminação, responsabilidades de cuidado e acesso aos serviços de saúde (ÅSLUND et al., 2014; MCEWEN, 2017).

O estresse ocupacional constitui outro exemplo de fenômeno que não pode ser reduzido à personalidade. Estudos sobre trabalhadores e profissionais de saúde associam exigências laborais, baixa autonomia, jornadas extensas e reduzido apoio organizacional a sintomas psicológicos e psicossomáticos. Essas relações devem ser interpretadas com atenção ao contexto institucional, pois uma intervenção centrada exclusivamente na capacidade individual de "lidar melhor" pode preservar as condições que produzem o sofrimento (KARASEK, 1979; ÅSLUND et al., 2014).

4 O QUE SIGNIFICA RECUPERAR A SAÚDE FÍSICA

A expressão "cura do corpo" só pode ser avaliada quando o desfecho está especificado. O fechamento de uma ferida, a deposição de colágeno, a redução da dor, a retomada de atividades, a melhora do sono, a qualidade de vida e a modificação de um marcador biológico são resultados diferentes. Eles podem ocorrer simultaneamente, mas um não deve ser utilizado como substituto automático do outro. A classificação contemporânea da dor crônica, por exemplo, reconhece dimensões de intensidade, sofrimento e incapacidade que exigem avaliação própria (TREEDE *et al.*, 2015).

Uma melhora subjetiva possui importância clínica mesmo quando não corresponde à reversão da causa da doença. Valorizar o relato do paciente não significa tratá-lo como prova de qualquer efeito biológico. Significa reconhecer que a experiência de saúde inclui sofrimento, funcionamento e participação social. Em pesquisas mente-corpo, medidas subjetivas e fisiológicas devem ser apresentadas separadamente, com indicação da duração dos efeitos e dos tratamentos realizados simultaneamente (HILTON *et al.*, 2017; KAPTCHUK *et al.*, 2010).

A cicatrização é especialmente útil para demonstrar essa distinção. Ela permite avaliar um processo corporal observável, mas envolve etapas diferentes, como inflamação, deposição de matriz, reepitelização e fechamento da ferida. Um marcador de colágeno pode sinalizar uma etapa do reparo sem demonstrar cicatrização completa. Portanto, a conclusão deve ser formulada segundo o indicador medido, e não segundo a expectativa ampla de "cura" (BROADBENT *et al.*, 2012; ROBINSON *et al.*, 2017).

5 A EXPERIÊNCIA DO ADOECIMENTO E SEUS SIGNIFICADOS

O modelo biopsicossocial oferece uma orientação para considerar níveis biológicos, psicológicos e sociais do adoecimento. Seu valor clínico depende de transformar essa orientação em perguntas e decisões pertinentes a cada situação. O modelo não dispensa investigação de mecanismos, não elimina a necessidade de diagnóstico e não autoriza reunir explicações incompatíveis apenas porque todas mencionam o ser humano em sua totalidade (BORRELL-CARRIÓ; SUCHMAN; EPSTEIN, 2004).

A medicina narrativa acrescenta atenção às histórias que as pessoas contam sobre o que lhes acontece. A competência narrativa envolve reconhecer, interpretar e responder à experiência do outro. A escuta pode esclarecer medos, expectativas, perdas, efeitos do tratamento e mudanças de identidade que não aparecem em uma descrição estritamente orgânica. Ela contribui para o cuidado porque amplia o conhecimento da vida vivida, não porque substitui a investigação clínica (CHARON, 2001).

Essa abertura exige cautela com a posição de quem interpreta. Uma narrativa de doença não é uma chave transparente para acessar toda a experiência de quem a vive. O paciente pode não encontrar sentido no adoecimento, pode rejeitar uma leitura de redenção ou pode preferir descrevê-lo em termos concretos. A escuta deve respeitar esses limites e não impor uma história de transformação pessoal como condição para que o sofrimento seja reconhecido (DUTTA, 2025).

Dethlefsen e Dahlke procuram compreender os sintomas por analogias e correspondências, associando partes do corpo a conflitos ou temas existenciais. Essa proposta pode ser estudada como concepção simbólica do adoecimento. Entretanto, quando a interpretação passa a afirmar que uma doença é causada por determinado conflito ou que será curada após sua resolução, a coerência interna da metáfora precisa ser substituída por investigação empírica compatível com a alegação (DETHLEFSEN; DAHLKE, 2002).

Há, portanto, diferença prática entre perguntar o que uma doença significa na vida de alguém e determinar previamente o conflito que ela supostamente representa. A primeira pergunta favorece uma narrativa situada e aberta; a segunda pode limitar o relato às expectativas de quem conduz a conversa. Uma abordagem rigorosa pode utilizar o significado subjetivo como dado clínico e comunicacional, sem convertê-lo automaticamente em causa orgânica (CHARON, 2001; DUTTA, 2025).

6 EVIDÊNCIAS SOBRE INTERVENÇÕES E RECUPERAÇÃO FÍSICA

Esta seção discute em profundidade os estudos empíricos do subconjunto selecionado. A Tabela 2 sintetiza suas características metodológicas antes da discussão narrativa detalhada por subseção.

Tabela 2 – Características metodológicas dos estudos empíricos discutidos em profundidade

Estudo	Desenho	Amostra	Intervenção (vs. comparador)	Desfecho	Resultado e limitação principal
KIECOLT-GLASER <i>et al.</i>, 1995	Observacional (comparação entre grupos)	Mulheres cuidadoras de familiares com demência vs. grupo-controle	Nenhuma intervenção testada; exposição = condição de cuidadora	Tempo de cicatrização de ferida por biópsia	Cicatrização mais lenta no grupo de cuidadoras; sustenta associação estresse-cicatrização, não eficácia de intervenção.
WALBURN <i>et al.</i>, 2009	Revisão sistemática com metanálise (22 estudos; 11 na metanálise)	Estudos sobre estresse e cicatrização publicados até 2007	Não aplicável (síntese de estudos observacionais)	Cicatrização de feridas	Associação combinada: pior cicatrização com maior estresse; heterogeneidade e busca desatualizada (até 2007).
BROADBENT <i>et al.</i>, 2012	Ensaio clínico randomizado	Pacientes submetidos à colecistectomia laparoscópica	Relaxamento e imaginação guiada vs. cuidado usual	Deposição de hidroxiprolina (colágeno) no 7º dia	Maior deposição de colágeno no grupo de intervenção; não equivale a fechamento completo da ferida.
ROBINSON <i>et al.</i>, 2017	Revisão sistemática de ensaios randomizados	Estudos sobre intervenções psicológicas e cicatrização	Intervenções psicológicas diversas (sobretudo relaxamento) vs. cuidado usual	Indicadores de cicatrização	Resultados favoráveis, sobretudo em feridas cirúrgicas; heterogeneidade e indícios de viés de publicação.
HILTON <i>et al.</i>, 2017	Revisão sistemática com metanálise de ensaios randomizados	Estudos sobre meditação de atenção plena e dor crônica	Meditação de atenção plena vs. cuidado usual/outras condições	Intensidade da dor, sintomas depressivos, qualidade de vida	Efeito pequeno favorável na dor, baixa qualidade da evidência; heterogeneidade

Estudo	Desenho	Amostra	Intervenção (vs. comparador)	Desfecho	Resultado e limitação principal
					e possível viés de publicação.
ASHAR <i>et al.</i>, 2022	Ensaio clínico randomizado	Adultos com dor lombar crônica primária	Terapia de reprocessamento da dor vs. placebo e cuidado usual	Medidas de dor	Resultados superiores ao placebo/cuidado usual; não generaliza a toda dor nem confirma mensagem simbólica universal.
KUO <i>et al.</i>, 2015	Estudo piloto aberto, sem grupo de controle	Pessoas com síndrome do intestino irritável ou doença inflamatória intestinal	Programa de relaxamento e habilidades cognitivas (9 semanas); sem comparador	Sintomas, ansiedade, qualidade de vida, expressão gênica	Mudanças observadas; sem controle, não é possível atribuir efeito a componente específico.
KAPTCHUK <i>et al.</i>, 2010	Ensaio clínico randomizado	Pessoas com síndrome do intestino irritável	Placebo aberto (sem engano) vs. ausência de tratamento	Melhora global e gravidade dos sintomas	Grupo placebo apresentou melhora; não transforma sintoma relatado em doença imaginária.
ÅSLUND <i>et al.</i>, 2014	Observacional transversal, grande amostra populacional	Amostra populacional geral adulta sueca	Não aplicável (exposições: estresse financeiro e apoio social tangível)	Bem-estar psicológico e sintomas psicossomáticos	Apoio material atenua parte da associação; desenho observacional não permite inferir causalidade.

Fonte: elaborado pelo autor com base na síntese apresentada neste artigo.

6.1 Estresse e cicatrização

Em um estudo clássico com mulheres cuidadoras de familiares com demência, feridas produzidas por biópsia demoraram mais para cicatrizar no grupo de cuidadoras do que no grupo de controle. O resultado associou um contexto de estresse à reparação mais lenta, mas não testou uma intervenção psicológica. Assim, o estudo sustenta uma hipótese sobre associação entre estresse e cicatrização, não uma conclusão de que reduzir o estresse produziria necessariamente o efeito inverso (KIECOLT-GLASER *et al.*, 1995).

Uma revisão sistemática sobre estresse psicológico e cicatrização reuniu 22 estudos, dos quais 11 foram incluídos na metanálise. A associação combinada indicou pior cicatrização em contextos de maior estresse, mas os trabalhos variaram quanto ao tipo de ferida, à população e à medida de estresse. Como a busca contemplou publicações até 2007, o resultado deve ser tratado como base histórica importante, não como síntese atualizada de todo o campo (WALBURN *et al.*, 2009).

Broadbent e colaboradores avaliaram uma intervenção breve de relaxamento e imaginação guiada associada ao cuidado usual em pacientes submetidos à colecistectomia laparoscópica. Entre os participantes randomizados que completaram o estudo, o grupo de intervenção apresentou maior deposição de hidroxiprolina sete dias após a cirurgia. Esse resultado sugere efeito em um marcador de deposição de colágeno, mas não equivale ao fechamento completo da ferida e não demonstrou que a mudança ocorreu exclusivamente pela redução do estresse percebido (BROADBENT *et al.*, 2012).

Em uma revisão de ensaios randomizados, Robinson e colaboradores encontraram resultados favoráveis a intervenções psicológicas sobre alguns indicadores de cicatrização, sobretudo em feridas cirúrgicas e intervenções de relaxamento. A heterogeneidade dos procedimentos, das populações e dos desfechos dificultou a combinação dos resultados, e os autores identificaram indícios de viés de publicação. A literatura oferece uma hipótese clínica promissora, mas não permite estender o efeito a toda doença ou substituir o cuidado médico (ROBINSON *et al.*, 2017).

6.2 Atenção plena e dor crônica

Hilton e colaboradores reuniram ensaios clínicos randomizados sobre meditação de atenção plena para dor crônica. A análise da dor encontrou um efeito pequeno favorável à intervenção, com baixa qualidade da evidência, enquanto os resultados para sintomas depressivos e qualidade de vida variaram conforme o desfecho. A conclusão adequada é que a atenção plena pode ser um componente auxiliar para algumas pessoas, e não que constitua tratamento universal ou prova de uma origem simbólica da dor (HILTON *et al.*, 2017).

A revisão também apontou heterogeneidade, possível viés de publicação, problemas metodológicos nos estudos primários e informação insuficiente sobre eventos adversos. Apenas parte dos ensaios acompanhou sistematicamente a segurança. Esses limites não anulam os resultados observados, mas reduzem a confiança em afirmações amplas e reforçam a necessidade de avaliação individualizada, cuidado usual e comunicação realista sobre benefícios e incertezas (HILTON *et al.*, 2017).

A dor reprocessada constitui exemplo diferente. Em um ensaio clínico com adultos com dor lombar crônica primária, uma intervenção voltada à modificação de crenças de ameaça apresentou resultados superiores ao placebo e ao cuidado usual em medidas de dor. O estudo é relevante porque mostra que crenças e expectativas podem participar da experiência dolorosa por meio de um procedimento definido. Ele não demonstra, contudo, que cada dor possua uma mensagem simbólica universal ou que a intervenção funcione para todas as condições (ASHAR *et al.*, 2022).

A diferença entre reprocessar uma previsão de ameaça e interpretar um órgão como símbolo de um conflito precisa ser preservada. No primeiro caso, a hipótese é operacionalizada, a intervenção é descrita e os desfechos são comparados. No segundo, a correspondência pode permanecer aberta a múltiplas interpretações e difícil de falsificar. A pesquisa clínica avançará quando os significados propostos puderem ser formulados antes da análise e comparados com explicações alternativas (ASHAR *et al.*, 2022; BAETHGE; GOLDBECK-WOOD; MERTENS, 2019).

6.3 Relaxamento, sintomas gastrointestinais e contexto terapêutico

Kuo e colaboradores investigaram um programa de nove semanas que combinava relaxamento e habilidades cognitivas em pessoas com síndrome do intestino irritável ou doença inflamatória intestinal. O estudo observou mudanças em sintomas, ansiedade, qualidade de vida e expressão gênica no sangue periférico. Sua natureza exploratória é decisiva: era um estudo piloto aberto, sem grupo de controle, e não permitia identificar qual componente do programa produziu os resultados (KUO *et al.*, 2015).

A ausência de comparador mantém abertas explicações como flutuação natural, expectativa, regressão à média, contato com a equipe e mudança de hábitos. Além disso, alterações de expressão gênica não equivalem a remissão clínica e não foram acompanhadas por mudanças claras em todos os marcadores inflamatórios avaliados. O estudo ilustra como dados biológicos e subjetivos podem ser reunidos sem autorizar uma conclusão de cura ou uma explicação simbólica específica (KUO *et al.*, 2015).

Em um ensaio com pessoas com síndrome do intestino irritável, Kaptchuk e colaboradores compararam placebo administrado de forma aberta com ausência de tratamento, mantendo interações de qualidade semelhante com os profissionais. O grupo que recebeu placebo apresentou melhora global e redução da gravidade dos sintomas durante o período estudado. O achado permite discutir expectativas, ritual terapêutico e relação clínica, mas não

transforma sintomas relatados em doença imaginária nem dispensa a investigação orgânica (KAPTCHUK *et al.*, 2010).

Esse conjunto de estudos sugere que o contexto terapêutico pode influenciar sintomas e qualidade de vida, especialmente em condições nas quais percepção, motilidade, sensibilidade visceral e comportamento interagem. A conclusão deve ser formulada com precisão: uma intervenção pode modificar a experiência e o funcionamento sem eliminar a causa de uma doença inflamatória ou anatômica. O benefício clínico não depende de afirmar que o sintoma seja apenas psicológico (KUO *et al.*, 2015; KAPTCHUK *et al.*, 2010).

7 DISCUSSÃO CRÍTICA

A literatura examinada sustenta a necessidade de separar desenhos de pesquisa e tipos de conclusão. Estudos observacionais descrevem associações; pesquisas mecanísticas investigam vias possíveis; ensaios clínicos avaliam intervenções; estudos narrativos analisam experiências e significados. O erro ocorre quando uma associação é apresentada como causa individual ou quando o efeito de uma intervenção é utilizado para confirmar uma teoria que não foi testada no estudo (ÅSLUND *et al.*, 2014; MCEWEN, 2017; KUO *et al.*, 2015).

A coexistência de resultados favoráveis e incertezas não é uma falha lógica da área, mas uma característica da pesquisa em saúde. Um efeito pequeno na dor pode coexistir com melhora de qualidade de vida; uma alteração em colágeno pode ocorrer sem fechamento completo da ferida; uma mudança em expressão gênica pode aparecer sem remissão clínica. A qualidade da argumentação depende de manter cada resultado associado ao desfecho e ao tempo em que foi medido (HILTON *et al.*, 2017; BROADBENT *et al.*, 2012; KUO *et al.*, 2015).

A dimensão emocional precisa ser abordada sem desqualificar o sofrimento. Revisões sobre gênero e dor descrevem normas e vieses que influenciam o reconhecimento das queixas e as decisões de cuidado, incluindo a tendência de psicologizar a dor de mulheres. Uma explicação psicológica pode ampliar a compreensão, mas também pode ser utilizada para encerrar prematuramente a investigação e reduzir a credibilidade atribuída ao paciente (SAMULOWITZ *et al.*, 2018).

Há igualmente o risco de responsabilizar a pessoa por condições que se desenvolvem sob circunstâncias que ela não controla. A análise de emoções, crenças e estratégias de enfrentamento deve considerar distribuição de recursos, experiências de violência, insegurança econômica, apoio disponível, discriminação e acesso ao tratamento. Reduzir essas condições a uma suposta atitude mental negativa produz uma explicação individualizante e enfraquece a relevância social da Psicologia da Saúde (ÅSLUND *et al.*, 2014; MCEWEN, 2017).

A matriz crítica proposta neste artigo organiza a passagem entre níveis de interpretação. Uma associação deve permanecer vinculada ao desenho que a observou. Uma hipótese de mecanismo deve ser examinada por indicadores compatíveis com a via proposta. Uma afirmação terapêutica exige intervenção caracterizada, comparador apropriado e desfechos definidos. Um significado subjetivo deve ser atribuído ao relato da pessoa, não imposto a partir de uma tabela universal de órgãos e conflitos (CHARON, 2001; BAETHGE; GOLDBECK-WOOD; MERTENS, 2019).

Tabela 3 – Matriz crítica de níveis de afirmação sobre relações mente-corpo

Categoria	Definição	Exemplo no artigo
Associação	Relação estatística entre exposição e desfecho, observada em estudo observacional, sem implicar causalidade direta.	Estresse de cuidadoras associado a cicatrização mais lenta (KIECOLT-GLASER <i>et al.</i> , 1995).
Mecanismo	Via fisiológica que pode explicar uma associação, investigada em nível celular, animal ou molecular; não resolve por si só uma questão clínica.	Carga alostática como desgaste acumulado de respostas de estresse prolongadas (MCEWEN, 2006; MCEWEN, 2017).
Intervenção	Procedimento psicológico testado em ensaio clínico, com comparador e desfecho definido, avaliando eficácia.	Relaxamento e imaginação guiada aumentando deposição de colágeno pós-cirúrgica (BROADBENT <i>et al.</i> , 2012).
Experiência	Relato subjetivo do paciente sobre sofrimento, sentido e vivência do adoecimento, colhido pela escuta clínica ou narrativa.	Competência narrativa e escuta da vida vivida do paciente (CHARON, 2001).
Interpretação simbólica	Atribuição de significado ou correspondência entre sintoma e conflito psíquico, não testada empiricamente como causa.	Leitura simbólica de Dethlefsen e Dahlke, tratada como hipótese hermenêutica, não como evidência clínica (DETHLEFSEN; DAHLKE, 2002).

Fonte: elaborado pelo autor com base na síntese apresentada neste artigo.

Essa matriz também ajuda a preservar uma contribuição legítima das interpretações simbólicas. Perguntar pelo sentido da doença pode favorecer comunicação, elaboração narrativa e identificação de necessidades que o exame biomédico não captura. O sentido pode orientar uma conversa clínica, uma decisão compartilhada ou uma intervenção psicoterapêutica. O que não se pode fazer sem evidência é transformar esse sentido em diagnóstico etiológico, promessa de cura ou explicação necessária de um processo biológico (DETHLEFSEN; DAHLKE, 2002; CHARON, 2001).

É importante distinguir a matriz proposta do modelo biopsicossocial, discutido na Seção 5 (BORRELL-CARRIÓ; SUCHMAN; EPSTEIN, 2004). O modelo biopsicossocial é uma orientação clínica que integra três níveis do adoecimento — biológico, psicológico e social —

para guiar a escuta e a decisão terapêutica, mas não estabelece, por si, critérios para diferenciar o grau de evidência de cada afirmação feita sobre esses níveis. A matriz crítica proposta neste artigo opera em outro plano: não descreve dimensões do adoecimento, mas classifica o tipo de afirmação epistemológica — associação, mecanismo, intervenção, experiência ou interpretação simbólica — que pode ser feita sobre qualquer uma dessas dimensões. As duas estruturas são complementares e não substituíveis entre si: o modelo biopsicossocial orienta o que observar na experiência do paciente; a matriz crítica orienta como avaliar a força do que foi observado ou relatado.

8 IMPLICAÇÕES PARA A PRÁTICA CLÍNICA E PARA A PESQUISA

Na prática clínica, uma abordagem mente-corpo rigorosa começa pela manutenção do diagnóstico e do tratamento indicados para a condição. A avaliação psicológica deve investigar sofrimento, expectativas, sono, funcionamento, adesão, relações sociais e estratégias de enfrentamento. O cuidado psicológico pode ser integrado ao tratamento sem ser apresentado como substituto do cuidado médico ou como prova de que a doença foi produzida pela mente (BORRELL-CARRIÓ; SUCHMAN; EPSTEIN, 2004; HILTON *et al.*, 2017).

A comunicação clínica deve distinguir hipótese, achado e recomendação. O profissional pode perguntar que significado o paciente atribui ao adoecimento, mas deve evitar afirmar que uma doença "representa" necessariamente raiva, medo, baixa autoestima ou dificuldade de adaptação. Essa postura reduz culpa, protege a autonomia e favorece uma escuta que reconhece a singularidade sem abandonar critérios de segurança e evidência (CHARON, 2001; DUTTA, 2025).

Essa distinção ganha urgência prática em um cenário de ampla circulação de conteúdos sobre "cura pela mente" em redes sociais, coaching de bem-estar e discursos de autoajuda pós-pandêmicos, que frequentemente reapresentam correspondências simbólicas como se fossem achados científicos estabelecidos. A matriz crítica proposta neste artigo oferece, nesse contexto, um instrumento de comunicação científica: permite que profissionais de saúde, educadores e formuladores de política distingam publicamente, com critérios explícitos, entre o que a evidência sustenta e o que permanece como interpretação não testada, contribuindo para o enfrentamento da desinformação em saúde.

Pesquisas futuras devem testar intervenções com descrição detalhada dos componentes, grupos de comparação, amostras adequadas, seguimento suficiente e medidas separadas de sintomas, função, qualidade de vida e reparação tecidual. Quando a hipótese envolver um mecanismo, os indicadores fisiológicos precisam ser definidos antes da análise. Quando

envolver significado simbólico, a interpretação deve ser operacionalizada, comparada com alternativas e avaliada quanto à confiabilidade entre diferentes avaliadores (ROBINSON *et al.*, 2017; BAETHGE; GOLDBECK-WOOD; MERTENS, 2019).

Também é necessário ampliar a diversidade das amostras e incorporar determinantes sociais. Estudos centrados apenas em indivíduos com acesso regular a serviços especializados podem produzir resultados pouco generalizáveis. Investigações futuras devem examinar como renda, raça, gênero, trabalho, território, escolaridade, apoio social e acesso ao tratamento modificam a relação entre estresse, intervenção psicológica e recuperação física (ÅSLUND *et al.*, 2014; SAMULOWITZ *et al.*, 2018).

9 LIMITAÇÕES

A principal limitação desta revisão decorre da seleção intencional do corpus e da restrição inicial a textos completos em acesso aberto. Estudos relevantes publicados fora das bases consultadas, em outros idiomas ou sem disponibilização gratuita podem não ter sido incluídos. A análise também não contou com revisores independentes para todas as etapas e não aplicou uma ferramenta formal de risco de viés ao conjunto integral dos trabalhos (BAETHGE; GOLDBECK-WOOD; MERTENS, 2019). Não houve registro prévio de protocolo, prática mais associada a revisões sistemáticas e metanálises do que a revisões narrativas, mas explicitada aqui por transparência metodológica.

A heterogeneidade dos temas impede uma síntese quantitativa única. Cicatrização, dor, sintomas gastrointestinais, qualidade de vida e marcadores moleculares não são desfechos intercambiáveis. O artigo, portanto, não estima a eficácia geral de "intervenções mente-corpo" nem permite ordenar todas as práticas segundo uma única escala. Sua contribuição é conceitual e metodológica: explicitar como diferentes evidências podem ser integradas sem apagar suas diferenças (HILTON *et al.*, 2017; ROBINSON *et al.*, 2017).

A insuficiência de evidência para confirmar correspondências simbólicas específicas também não equivale à refutação de toda experiência de significado. O que os estudos examinados demonstram é que uma interpretação subjetiva e uma afirmação causal são proposições diferentes. Avançar nesse campo exige pesquisas capazes de separar o efeito da narrativa, da relação terapêutica, da expectativa, da mudança comportamental e do tratamento médico concomitante (DETHLEFSEN; DAHLKE, 2002; KUO *et al.*, 2015).

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A literatura examinada oferece fundamentos para investigar a contribuição de processos psicológicos à recuperação física. Na Psicologia da Saúde, essa contribuição pode ser formulada em termos de mecanismos de estresse, mudanças de sintomas, recuperação funcional, qualidade de vida e reparação tecidual, sempre vinculados à condição estudada. Os resultados permitem desenvolver perguntas clínicas sobre quando, para quem e por quais vias o cuidado psicológico pode ajudar, mas não sustentam uma promessa geral de cura pela mente (MCEWEN, 2017; HILTON *et al.*, 2017; ROBINSON *et al.*, 2017).

O principal limite das interpretações simbólicas aparece quando um sentido atribuído ao adoecimento é apresentado como explicação clínica comprovada. Reconhecer a subjetividade do paciente, escutar sua narrativa e avaliar intervenções psicológicas são tarefas compatíveis com rigor científico. Para isso, as conclusões precisam permanecer proporcionais ao que os estudos observaram: melhora de sintomas, mudanças de qualidade de vida, alterações de marcadores e reparação de tecidos exigem descrições próprias e não devem ser reunidas indistintamente sob a palavra "cura" (HILTON *et al.*, 2017; KAPTCHUK *et al.*, 2010; BROADBENT *et al.*, 2012).

A perspectiva mais produtiva não é escolher entre corpo e mente, mas formular perguntas que tornem a relação investigável e clinicamente responsável. O cuidado psicológico pode reduzir sofrimento, favorecer adaptação, modificar comportamentos, melhorar a experiência de sintomas e, em algumas condições, participar de processos corporais mensuráveis. Essa contribuição ganha força quando é integrada ao cuidado clínico, situada nas condições sociais de vida e apresentada com transparência sobre seus limites (BORRELL-CARRIÓ; SUCHMAN; EPSTEIN, 2004; ÅSLUND *et al.*, 2014).

DECLARAÇÕES

Conflitos de interesse

O autor declara não haver conflitos de interesse.

Financiamento

Esta pesquisa não recebeu financiamento de agências de fomento públicas, privadas ou sem fins lucrativos.

Disponibilidade de dados

Não aplicável. Este artigo é uma revisão narrativa e não gerou conjuntos de dados originais. Todas as fontes analisadas estão referenciadas e publicamente disponíveis em acesso aberto, com DOI e links de acesso indicados nas referências.

Contribuição de autoria (CRediT)

Carlos Hernane de Oliveira: conceituação, investigação, metodologia e redação (rascunho original, revisão e edição).

REFERÊNCIAS

ASHAR, Yoni K. *et al.* Effect of pain reprocessing therapy vs placebo and usual care for patients with chronic back pain: a randomized clinical trial. *JAMA Psychiatry*, v. 79, n. 1, p. 13-23, 2022. DOI: 10.1001/jamapsychiatry.2021.2669. Disponível em: <https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2021.2669>. Acesso em: 21 set. 2026.

ÅSLUND, Cecilia *et al.* The buffering effect of tangible social support on financial stress: influence on psychological well-being and psychosomatic symptoms in a large sample of the adult general population. *International Journal for Equity in Health*, v. 13, art. 85, 2014. DOI: 10.1186/s12939-014-0085-3. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s12939-014-0085-3>. Acesso em: 21 set. 2026.

BAETHGE, Christopher; GOLDBECK-WOOD, Sandra; MERTENS, Stephan. SANRA: a scale for the quality assessment of narrative review articles. *Research Integrity and Peer Review*, v. 4, art. 5, 2019. DOI: 10.1186/s41073-019-0064-8. Disponível em: <https://doi.org/10.1186/s41073-019-0064-8>. Acesso em: 21 set. 2026.

BORRELL-CARRIÓ, Francesc; SUCHMAN, Anthony L.; EPSTEIN, Ronald M. The biopsychosocial model 25 years later: principles, practice, and scientific inquiry. *Annals of Family Medicine*, v. 2, n. 6, p. 576-582, 2004. DOI: 10.1370/afm.245. Disponível em: <https://doi.org/10.1370/afm.245>. Acesso em: 21 set. 2026.

BROADBENT, Elizabeth *et al.* A brief relaxation intervention reduces stress and improves surgical wound healing response: a randomised trial. *Brain, Behavior, and Immunity*, v. 26, n. 2, p. 212-217, 2012. DOI: 10.1016/j.bbi.2011.06.014. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.bbi.2011.06.014>. Acesso em: 21 set. 2026.

CHARON, Rita. Narrative medicine: a model for empathy, reflection, profession, and trust. *JAMA*, v. 286, n. 15, p. 1897-1902, 2001. DOI: 10.1001/jama.286.15.1897. Disponível em: <https://doi.org/10.1001/jama.286.15.1897>. Acesso em: 21 set. 2026.

DETHLEFSEN, Thorwald; DAHLKE, Rüdiger. *A doença como caminho*. Cascais: Pergaminho, 2002.

DUTTA, Rajeev. The limitations of narrative medicine. *Theoretical Medicine and Bioethics*, v. 46, n. 3, p. 247-264, 2025. DOI: 10.1007/s11017-025-09713-6. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s11017-025-09713-6>. Acesso em: 21 set. 2026.

EUROPE PMC. *Europe PMC: a full-text literature database for the life sciences and biomedical sciences*. Disponível em: <https://europepmc.org/>. Acesso em: 21 set. 2026.

HILTON, Lara *et al.* Mindfulness meditation for chronic pain: systematic review and meta-analysis. *Annals of Behavioral Medicine*, v. 51, n. 2, p. 199-213, 2017. DOI: 10.1007/s12160-016-9844-2. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s12160-016-9844-2>. Acesso em: 21 set. 2026.

KAPTCHUK, Ted J. *et al.* Placebos without deception: a randomized controlled trial in irritable bowel syndrome. *PLoS ONE*, v. 5, n. 12, e15591, 2010. DOI: 10.1371/journal.pone.0015591. Disponível em: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0015591>. Acesso em: 21 set. 2026.

KARASEK, Robert A. Job demands, job decision latitude, and mental strain: implications for job redesign. *Administrative Science Quarterly*, v. 24, n. 2, p. 285-308, 1979.

KIECOLT-GLASER, Janice K. *et al.* Slowing of wound healing by psychological stress. *The Lancet*, v. 346, n. 8984, p. 1194-1196, 1995. DOI: 10.1016/S0140-6736(95)92899-5. Disponível em: [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(95\)92899-5](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(95)92899-5). Acesso em: 21 set. 2026.

KUO, Braden *et al.* Genomic and clinical effects associated with a relaxation response mind-body intervention in patients with irritable bowel syndrome and inflammatory bowel disease. *PLoS ONE*, v. 10, n. 4, e0123861, 2015. DOI: 10.1371/journal.pone.0123861. Disponível em: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0123861>. Acesso em: 21 set. 2026.

MCEWEN, Bruce S. Protective and damaging effects of stress mediators: central role of the brain. *Dialogues in Clinical Neuroscience*, v. 8, n. 4, p. 367-381, 2006. DOI: 10.31887/DCNS.2006.8.4/bmcewen. Disponível em: <https://doi.org/10.31887/DCNS.2006.8.4/bmcewen>. Acesso em: 21 set. 2026.

MCEWEN, Bruce S. Neurobiological and systemic effects of chronic stress. *Chronic Stress*, v. 1, 2017. DOI: 10.1177/2470547017692328. Disponível em: <https://doi.org/10.1177/2470547017692328>. Acesso em: 21 set. 2026.

PIZZINO, Gabriele *et al.* Oxidative stress: harms and benefits for human health. *Oxidative Medicine and Cellular Longevity*, v. 2017, art. 8416763, 2017. DOI: 10.1155/2017/8416763. Disponível em: <https://doi.org/10.1155/2017/8416763>. Acesso em: 21 set. 2026.

ROBINSON, Hayley *et al.* The effects of psychological interventions on wound healing: a systematic review of randomized trials. *British Journal of Health Psychology*, v. 22, n. 4, p. 805-835, 2017. DOI: 10.1111/bjhp.12257. Disponível em: <https://doi.org/10.1111/bjhp.12257>. Acesso em: 21 set. 2026.

SAMULOWITZ, Anke *et al.* "Brave men" and "emotional women": a theory-guided literature review on gender bias in health care and gendered norms towards patients with chronic pain. *Pain Research and Management*, v. 2018, art. 6358624, 2018. DOI: 10.1155/2018/6358624. Disponível em: <https://doi.org/10.1155/2018/6358624>. Acesso em: 21 set. 2026.

TREEDE, Rolf-Detlef *et al.* A classification of chronic pain for ICD-11. *Pain*, v. 156, n. 6, p. 1003-1007, 2015. DOI: 10.1097/j.pain.000000000000160. Disponível em: <https://doi.org/10.1097/j.pain.000000000000160>. Acesso em: 21 set. 2026.

WALBURN, Jessica *et al.* Psychological stress and wound healing in humans: a systematic review and meta-analysis. *Journal of Psychosomatic Research*, v. 67, n. 3, p. 253-271, 2009. DOI: 10.1016/j.jpsychores.2009.04.002. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2009.04.002>. Acesso em: 21 set. 2026.